

Erihoolekandes on nii muresid kui ka rõõmustavaid arenguid



Maarja Kraiss-Leosk

nõunik, sotsiaalministeerium

Erihoolekandeteenused on olnud pidevas arengus. Paranenud on keskkond, kus teenuseid pakutakse, ja ka teenuse saajate elus on palju muutunud: tänu isikukesksele lähenemisele on neil nüüd hoopis rohkem otsustus- ja valikuvabadust.

Järjest rohkem teenuseosutajaid kasutab tõenduspõhist metoodikat ja rehabilitatsiooniteenuseid. Viimastel aastatel on eraldi rahastuse saanud teenused mitmele lisatuge vajavale sihtgrupile, käivad arutelud täiendavate teenuste rahastamiseks. Koostöös omavalitsustega katsetatakse uut teenusmudelit, mille eesmärk on tuua toimetulekuks vajalikud abimeetmed inimesele võimalikult lähedale. Erihoolekandeteenuste areng on väga oluline ka seepärast, et paremad teenused leevendavad omaste koormust.

Hoolekande aluspõhimõtted: vajaduspõhine ja inimõigusi austav toetus

Viimastel aastatel on seoses erihoolekande reorganiseerimisega palju räägitud deinstitsionaliseerimisest (DI) ehk üleminekust asutusekeskselt teenuste osutamiselt kogukonnapõhisele hoolekandele. DI mõiste on märksa laiem kui suurte asutuste sulgemine ja inimeste kolimine väiksematesse üksustesse, eramutesse ja korteritesse. Isikukeskne, vajaduspõhine, kaasav ja inimese õigusi austav toetus on oluline hoolekande kõigi sihtgruppide puhul. Need

põhimõtted peavad kujunema hoolekandeteemade käsitlemise, teenuste planeerimise ja arendamise aluseks ning seda nii riigi kui kohaliku tasandi arengudokumentides ja õigusaktides.

Ka poliitikauuringute keskus Praxis tõi oma pikaajalist hooldust käsitlevas analüüsis (Aaben jt 2017) välja, et DI reformide keskmeks on lähtekoht, et hooldust vajavad inimesed peaksid saama elada võimalikult kaua oma kodus või saama teenuseid kodu meenutavas kogukondlikus hoolekandenasutuses. Selle muutuse eesmärk on edasi lükata intensiivsema hooldusvajaduse väljakujunemist ja parandada pikaajalist hooldust vajavate inimeste elukvaliteeti. Sama põhimõte laieneb kõigile sotsiaalteenustele.

Saja-aastane Eesti ei ole riik, kus inimene pannakse oma eripära tõttu kuhugi asutusse silma alt ära. Vastupidi, saja-aastases Eestis püüame luua uusi võimalusi, et inimestele saaks abi pakkuda inimväärses tingimustes. Väga kurb oli lugeda veebruaris Eesti Päevalehes ilmunud loost (Ibrus 2018), kuidas valla esindaja ei näinud mingit probleemi selles, et nende poole pöördunud liikumisvõimetu IT-spetsialisti pere

vajadusi ei hinnatud ega otsitud võimalusi, kuidas perele teenuseid osutada. Öeldakse, et inimene peab oma olukorraga leppima, mis siis, et tal on tööoskused, pere tugi ning tahtmine tegutseda. Hoolekande arengu ning kõiki inimesi kaasava ja austava ühiskonna põhimõtetega on selline suhtumine väga suures vastuolus, seda ei tohiks lubada ei erihoolekande- ega ka teisi hoolekandeteenuseid vajavate inimeste puhul.

Erihoolekandetasutuste kaasajastamise kogemus on seni ainult kinnitanud, et oleme õigel teel: teenuste kasutajad on muutunud iseseisvamaks ja rahulolevamaks. Inimesed, kes veel 2000. aastate algul hooldekodusse suunati, tulevad nüüd oma igapäevase eluga ise toime: nad õpivad, teevad koduseid

töid, planeerivad oma eelarvet ja osalevad kogukonna üritustes.

Psüühilise erivajadusega inimene ehk „riigi inimene“?

Kas psüühilise erivajadusega inimese eest peaks hoolitsema ainult riik? Kindlasti mitte. Nagu igal teiselgi selle piirkonna abivajaval kodanikul on psüühikahäirega inimesel õigus kohaliku omavalitsuse abile ja toele, liiati siis, kui kohalik omavalitsus on inimese eestkostja. Riik finantseerib erihoolekandeteenuseid, kuid see ei tähenda, et kohalik omavalitsus ei peaks vajaduse korral abi andmist korraldama ja tagama. Kohalik omavalitsus vastutab oma inimestele vajaliku sotsiaalhoolekande korraldamise eest,

Erihoolekandeteenuse eelarve ja teenusekohad

- Erihoolekandeteenuste eelarve on aasta-aastalt suurenenud: 2013. aastal oli see 17,5 miljonit eurot, 2018. aastal 29 miljonit eurot.
- Juurde on loodud uusi teenusekohti ning kaasajastatud olemasolevaid. Aastatel 2013–2017 on riigi rahastusel juurde loodud u 2000 teenusekohta, Euroopa Regionaalarengu Fondi toel on alates 2007. aastast valminud ja valmimas veel ligi 2000 teenusekohta üle Eesti. Kui seni pakuti teenuseid suurtes hoonetes, mis asusid sageli tiheasustusega keskustest eemal, siis reorganiseeritud teenusekohtades on nii teenust vajavatel inimestel kui töötajatel igati head ja kaasaegsed tingimused. Sama meetme toel luuakse lähiaastatel veel u 400 uut teenusekohta Eesti eri paikadesse.
- 1. aprilli seisuga finantseeris Sotsiaalkindlustusamet kokku u 7000 teenusekohta. Oluliselt on kasvanud nende teenuste osutamise maht, mis toetavad inimese elamist kodus. Samuti on kasvanud kogukonnas elamise teenuse osutamine. Selle puhul elavad ühes majas või külas koos inimesed, kes saavad hakkama ilma ööpäevase toeta, kuid aeg-ajalt vajavad siiski juhendamist, suunamist ja nõustamist.
- Alates 2018. aastast rahastatakse lisaks erihoolekandeteenustele paindliku intervallhoiu ja igapäevaelu toetamise teenust, mis on mõeldud raske ja sügava intellektihäire ja suure hooldevajadusega inimestele. Esimesel aastal on eesmärgiks rahastada 200 uut teenusekohta, edaspidi on kavas teenusekohtade arvu kasvatada. Kõik asjast huvitatud teenuseosutajad ja kohalikud omavalitsused on oodatud Sotsiaalkindlustusametiga ühendust võtma.
- Sotsiaalkindlustusamet lõi aprillis juurde üle 500 uue erihoolekande teenusekoha, mis võimaldas järjekorras oodanud inimestel teenusele pääseda. 2018. aasta lõpuks hakkab erihoolekandeteenuseid saama ligi 8000 inimest.
- Nii intellekti- kui psüühikahäirega inimesed on alates 2016. aastast saanud kasutada pikaajalist kaitstud töötamise teenust. Selle teenuse osutamist jätkatakse ka edaspidi.

sest kohapeal on lihtsam leida inimestele sobivaid lahendusi. Kuna sotsiaalvaldkonna rahastus on piiratud, tuleb teha koostööd ning maksimaalselt kaasata ka kogukonna ressursse. Positiivne, et on kohalikke omavalitsusi, kes riiklike võimaluste kõrval arendavad ka ise teenuseid psüühilise erivajadusega inimestele, näiteks tugiisikuteenust.

Kohalikul sotsiaaltöötajal tuleb nõustada nii inimest kui tema lähedasi või eestkostjat, kellele tuleb selgitada erinevaid võimalusi ja pakkuda abi asjaajamisel. Abivajajal on keerukas süsteemis orienteeruda ja endale sobivaid meetmeid valida – inimesed ei tea, kellelt, mida ja kuidas küsida. Erihoolekandeteenustega seotud küsimuste lahendamisel on abiks Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud juhtumikorraldajad.

Kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal on infot pere kohta, kes on oma raske või sügava intellektihäire ja suure hooldusvajadusega lähedast seni kodus hooldanud, siis tuleb ka neile tutvustada uusi võimalusi ja teenuseid. Selliste teenuste pakkumist peaksid omavalitsused kindlasti oma piirkonnas ka soodustama. Alates sellest aastast finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu intervallhoidu, see paindlik teenus arvestab suurel määral inimese ja tema omaste vajadusi. Näiteks saab teenuse kasutamise aega valida kuus 21 (öö)päeva piires ning inimene võib olla teenusel kas ainult päeval, terve ööpäeva, öhtusel ajal, nädalavahetusel või mõne päeva kuus sõltuvalt hoolduskoormusega pere vajadustest, et omaksed saaks võimaldada endale puhkust, säilitada töökoha, naasta tööellu jne.

Kus peaks inimene teenuseid saama?

Aeg, mil inimene saadeti psüühilise erivajaduse tõttu Eesti teise otsa hooldekodusse,

on möödas. Senised haigla tüüpi, keskustest eemal asuvad ja enam kui sajale inimesele mõeldud hooldusasutused ei meenutanud kuidagi keskkonda, kus inimesed saaksid oma võimeid rakendada, areneda, taastuda ja valmistuda iseseisvamaks eluks.

Elamine asulas, kus on pood, bussipeatus, apteek, raamatukogu, kultuurikeskus või isegi kino, pakub psüühilise erivajadusega inimestele täiesti uusi võimalusi. Kuidas saaks inimene mõista näiteks seda, kuidas apteegis toimida, kui tal polegi võimalik sinna sattuda, rääkimata sellest, et õppida, kuidas apteegis oma asju ajada? Kõige olulisem muutus on aga see, et inimesed saavad nüüd ise otsustada ja kaasa rääkida kõigil teemadel, mis nende argielu puudutavad: näiteks mida süüa teha; kes, kellega ja mis kell poodi läheb; kui palju ja millist toitu osta saab; millisele üritusele ja kellega minna jne. See ei ole enam lihtsalt supisabas seismine ja päevakavas näpuga järje ajamine.

Kui ilmneb vajadus mingi teenuse järele, siis inimene ei pea oma kodukandist lahkuma. Ta võib seda teha, kuid see ei tohiks olla tema ainuke valik. Inimene peab saama elada kodus või kodu lähedal ning kontakt oma pere, sõprade ja suhtevõrgustikuga peab säilima. Uute kohtade loomisel lähtume sellest, et need paikneksid asulates, kus on kättesaadavad ka teenused. Teenusekohti on nii väiksemates kui suuremates asulates ja ka linnades. Oluline on hajutada teenuse osutamise kohti, et ei tekiks mammutasutusi, kus kõik sotsiaalteenused on kokku pandud. Koduse elukeskkonna saab luua korteris, eramus, paarismajas. Teenuste osutamine erihoolekannet vajavatele inimestele nende kodudes on täiesti loomulik. Erihoolekandeteenuste kõrval on teisigi sotsiaalteenuseid, mida osutades nt isiklik abistaja, tugiisik või hooldustöötaja käib inimese juures kodus.

Kui selgub, et inimesele teenus siiski ei sobi, siis hinnatakse tema olukorda uuesti ja vajaduse korral leitakse talle muu teenus või asukoht. Senise kogemuse põhjal on ASi Hoolekandeteenused suurtest hooldekodudest või peremajadest iseseisvamasse ellu astunud inimestest ainult u 1% suundunud tagasi ööpäevaringsele hooldusele. Midagi imelikku ei ole selles, kui rohkem kui paarisaja inimese seas leidub mõni üksik, kellele uus elukorraldus ja iseseisvus siiski ei sobi või kellel on esinenud tagasilööke tervises. Näiteks ei saa kõik inimesed ilma kontrollita ise oma ravimeid võetud jne. See aga ei tähenda, et nad peaksid elama suures hooldekodus, neile võib sobida nt peremaja tüüpi elukorraldus, kus tegevusjuhendaja tugi on pidevalt kättesaadav.

Tunnustan tubli töö eest kõiki teenuseosutajaid ja tegevusjuhendajaid, kes on teenust kasutavaid inimesi nii hästi uueks eluks ette valmistanud, et tagasilanguste protsent on minimaalne. Teie järjekindla tegevuse viljaks ongi eluga paremini toimetulevad, oluliselt rahulolevamad ja tunduvalt vabamad inimesed. Mitmed neist käivad juba tööl, omandavad haridust või õpivad uut ametit ja oskusi.

Väljakutsed ja prioriteedid

Erihoolekanne ei ole mugavusteenus, sageli on tegu hoopis eluks vajaliku toega. Kuigi erihoolekandeteenuste eelarve on aasta-aastalt kasvanud, on sellele teenusele endiselt järjekorrad. Aprilli seisuga oli erihoolekandeteenuse järjekorras 1362 inimest, kellest 847 vajas teenust kohe. Teised olid end järjekorda pannes öelnud, et nad kohe teenusele minna ei soovi. Sotsiaalkindlustusamet lõi aprillis juurde üle 500 uue toetava erihoolekande teenusekoha, mis võimaldab järjekorras oodanud inimestel kohe teenusele pääseda. Kasvava teenuste nõudluse tõttu on

vaja pidevalt kontrollida eelarve kasutamist ja teha otsuseid, milliseid teenuseid, kuhu ja kuidas juurde luua. Lisaks lisarahastuse taotlemisele riigieelarvest on kavas viia ka erihoolekandeteenuste vajaduse tuvastamine Sotsiaalkindlustusameti pädevusse ning vaadata üle teenust juba saavate inimeste vajadused, eesmärgiks õige inimene õigel teenusel.

Kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid ei saaks pakkuda ilma pühendunud, koolitatud ja motiveeritud tegevusjuhendajateta. Madal töötasu on põhjus, miks valdkonnast huvitatud inimesed sellele tööle ei tule või endale muu ameti otsivad. Uuest aastast on tänu riigieelarve läbirääkimistel tehtud otsustele võimalik tõsta ka erihoolekandetöötajate palka. Sotsiaalministeeriumis on kavandamisel projekt, mille kaudu saaks pakkuda tegevusjuhendajatele supervisiooni.

Kestab uue teenusmudeli testimine, kus psüühilise erivajadusega inimestele vajalike erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse korralduse ja kättesaadavuse eest vastutab kohalik omavalitsus. Teenusmudeli väljatöötamisel pidasid erivajadusega inimesed ja nende omaksed teenuste paindlikkuse ja isikukesksuse seisukohast parimaks just sellist lahendust, kus teenused saab esmasjärgulise kohaliku omavalitsuse kaudu. Katsetatud mudeli laiem kasutuselevõtt ei toimu üleöö, esmalt tuleb saavutada omavalitsuste võimekus ja valmisolek teenuseid uut moodi korraldada.

Lõpetuseks

Erihoolekande ümberkorraldamisel me enam ei aruta, kas ja miks seda üldse teha, nüüd on aeg käes, et mõelda ja otsustada, kuidas psüühilise erivajadusega inimestele kõige paremini neile sobivat tuge pakkuda. Psüühilise erivajadusega inimeste arv on